

CURAS FÍSICAS ATRIBUÍDAS A TRATAMENTOS ESPIRITUAIS NO ESPIRITISMO: UM RELATO DE CASO*

DOI 10.18224/frag.v33iEsp.13487

CAROLINA ROBERTA OHARA BARROS E JORGE DA CUNHA**
FABIO SCORSOLINI-COMIN***

Resumo: a literatura científica tem reportado casos de pacientes que tiveram melhora de sintomas de saúde atribuídos a intervenções espirituais. O objetivo deste estudo é relatar um caso de cura física de um nódulo de mama atribuída a um tratamento espiritual (TE). Trata-se de um estudo de caso desenvolvido a partir da abordagem qualitativa, por meio de entrevista realizada em um centro espírita. A participante narrou que, após detectar um nódulo de mama com características malignas, submeteu-se ao TE. Na posterior biópsia, não foram identificadas formações nodulares. A participante atribuiu essa condição ao efeito do TE. Como pesquisadores no campo da etnopsicologia, é mister que nos afastemos de julgamento moral ou de realidade em relação ao relato em tela. O acolhimento das diferentes experiências de saúde-doença-cuidado, sobretudo no campo da atuação em saúde, em uma posição de respeito e de genuíno interesse, pode contribuir para a integração de diferentes inteligibilidades.

Palavras-chave: Espiritismo. Terapias Espirituais. Espiritualidade.

Antropologia apresenta uma contribuição importante para a construção de um novo paradigma de saúde-doença-cuidado que ultrapasse a fragmentação e o foco exclusivo na doença. Em consonância com os grandes avanços da ciência biomédica, temos também o avanço do pensamento de um modelo que não é estritamente biológico e individual, mas que abarca também os processos sociais, coletivos e culturais. Cientes disso, reconhecer que a biomedicina não é o único sistema de saúde de referência é essencial (LANGDON, 2014).

Embora a biomedicina ainda seja o sistema dominante que orienta o processo saúde-doença-cuidado, existem diversos outros sistemas ou outras práticas terapêuticas operando concomitan-

* Recebido em: 25.05.2023. Aprovado em: 27.06.2023.

** Doutoranda do Programa Pós-graduação Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. *E-mail:* carolinaohara@usp.br

*** Doutor em Psicologia, Professor Associado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. *E-mail:* fabio.scorsolini@usp.br

temente (LAPLANTINE, 2004; LANGDON, WILK, 2010; MONTERO, 1985) no Brasil e em diversos outros países (principalmente nos países em desenvolvimento), sendo vários deles ligados a movimentos religiosos e práticas de curandeirismo ou medicina tradicional (MONTERO, 1985; GUREJE *et al.*, 2015). Em suma, esses movimentos reconhecem a insuficiência do paradigma biomédico tanto para explicar um processo de adoecimento, por exemplo, como para acompanhar o itinerário terapêutico de pacientes/clientes.

Tomando por referência os saberes etnopsicológicos, por exemplo, é impossível construir uma prática profissional de cuidado desassociada das etnoteorias de cada povo e de cada comunidade. Nessa perspectiva, portanto, opera-se o reconhecimento não de um sujeito fragmentado, como descrito no modelo biomédico, mas de um ser integrado, o que envolve a consideração, por exemplo, de suas religiosidades/espiritualidades (SCORSOLINI-COMIN, 2023). Se essas religiosidades/espiritualidades possuem grande representação quando pensamos os processos de saúde-doença-cuidado, inclui-las na compreensão dos itinerários terapêuticos é uma forma de tomar como referência as crenças trazidas pelo sujeito, a sua ancestralidade e o modo como constrói inteligibilidades sobre o mundo e sobre o viver.

Para além dos sistemas de saúde existentes e funcionantes, a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde formais, normalmente biomédicos, principalmente em países de baixa renda, aumenta a procura por cuidados de saúde como os populares, baseados em curandeirismo e os promovidos por instituições religiosas, por exemplo (GUREJE *et al.*, 2015). Para se ter uma ideia, no que se refere à saúde mental, entre 76 e 85% das pessoas com transtornos mentais graves não recebem tratamento em países de baixa e média renda (WHO, 2021). Por outro lado, outro estudo relata que entre 20 e 80% da população com problemas de saúde mental fazem uso de tratamentos oferecidos por cuidadores tradicionais, e outras práticas como fitoterapia, entre outros (PHAM *et al.*, 2021; GUREJE *et al.*, 2015).

Tratando-se do Brasil, ao analisar o sistema cultural de saúde, a busca etiológica ou ainda dos possíveis tratamentos ultrapassa o sistema biomédico, incluindo nesse repertório a busca por especialistas não reconhecidos pela biomedicina, tais como benzedeiros, curandeiros, pais de santo, pastores, dentre outros. Esse sistema que permite a porosidade entre esses modelos explicativos faz parte do contexto social e cultural brasileiro, de modo que a participação das religiosidades/espiritualidades nos processos de saúde-doença-cuidado mostra-se uma realidade (LANGDON, WILK, 2010; MELO, CABRAL, SANTOS JÚNIOR, 2009; SILVA, SCORSOLINI-COMIN, 2020).

Entre os locais que podem ser procurados para cuidados em saúde estão os centros espíritas. O espiritismo ou doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, possui estreita relação com os processos de saúde e doença desde a sua gênese, e uma base explicativa desses processos como sendo de origem espiritual (AUBRÉE; LAPLANTINE, 2009), ou reencarnatória, como extensivamente já estudado, e, por muitas vezes, demonstrado por doenças ou sinais de nascença (MOREIRA-ALMEIDA; COSTA; COELHO, 2022). Seja na busca etiológica das doenças ou na indicação de tratamentos e processos de cura, há uma vasta literatura espírita publicada que tenta explicar esses fenômenos e recomendar a utilização de suas terapias. Entre os modelos explicativos para a etiologia das doenças comumente são citados os processos obsessivos, em que o doente ou obsidiado sofre a ação de um ou de vários espíritos com o objetivo de lhe prejudicar. Ou, ainda, aqueles em decorrência de ações deletérias ocorridas em vidas passadas, denominados de doenças expiatórias, também designadas de carma em outros seguimentos religiosos (KARDEC, 2013).

A literatura científica tem cada vez mais reportado casos de pacientes que tiveram melhora de sintomas de saúde física e mental a partir de intervenções espirituais, como as chamadas tera-

pias espíritas. Estudos com diferentes níveis de evidência têm dado suporte a essa consideração (LUCCHETTI *et al.*, 2015; CARNEIRO *et al.*, 2018; CARNEIRO *et al.*, 2017; CARNEIRO *et al.*, 2020a; CARNEIRO *et al.*, 2020b; CAVALCANTE *et al.*, 2016).

Essas investigações, no entanto, partem de um paradigma de pesquisa, a baseada em evidências, que é construída e reforçada pelo modelo biomédico. Assim, até mesmo os critérios para o reconhecimento das doenças, suas causas e avaliação de resultados tomam por base metodologias consideradas robustas e que, muitas vezes, não são capazes de capturar particularidades do fenômeno que se pretende compreender. Não se trata, aqui, de refutar os achados desses estudos, que se mostram importantes para a inclusão das religiosidades/espiritualidades e das chamadas terapias espirituais no rol de tratamentos possíveis no contexto de cuidado culturalmente referenciado, mas de elencar a necessidade de que, a esses delineamentos, sejam incluídas propostas que permitam o acompanhamento de processos individuais e de particularidades que incidem sobre os sujeitos nesses itinerários. A partir desse panorama e considerando essa lacuna, o objetivo deste estudo é relatar um caso de cura física de um nódulo de mama com características malignas atribuída, pela entrevistada, a um tratamento espiritual.

MÉTODO

Este estudo de caso foi desenvolvido dentro de uma investigação maior sobre os efeitos do tratamento espiritual na saúde física e mental de seus adeptos, a partir uma pesquisa qualitativa com um olhar etnopsicológico. Isso coloca em tela a necessidade de construção de um referencial de análise que não tome por base apenas os elementos de um saber biomédico, por exemplo, mas as etnoteorias presentes na coletividade a qual o sujeito pertence (SCORSOLINI-COMIN, 2023). Em se tratando da etnopsicologia, deve-se reconhecer que os critérios de cura, por exemplo, devem ser pensados a partir dos relatos dos sujeitos e dos referenciais culturais construídos e que podem atestar se, de fato, ocorreu ou não a cura de uma determinada patologia ou de um determinado sofrimento, por exemplo, sem a emissão de julgamentos morais ou de realidade sobre esses modelos explicativos (LAPLANTINE, 2004; SCORSOLINI-COMIN, 2018).

Um roteiro de entrevista foi desenvolvido pelos autores responsáveis pelo estudo e aplicado aos participantes do tratamento espiritual realizado em um centro espírita na cidade de Cuiabá/MT, no ano de 2022. A entrevista ocorreu em dois momentos, a saber, no momento anterior à realização do tratamento espiritual e posteriormente à conclusão deste. O roteiro da primeira entrevista continha perguntas sobre os motivos para a busca do tratamento espiritual, experiências prévias, expectativas. E, no segundo roteiro, aplicado após o tratamento, havia questões sobre percepções quanto ao processo de saúde-doença-cuidado, possíveis efeitos positivos e negativos percebidos pelo voluntário, bem como impressões sobre o itinerário terapêutico.

Para o presente estudo, foi selecionado o caso de uma das pessoas entrevistadas e acompanhadas ao longo da pesquisa. O estudo de caso é a investigação de um ou mais casos, podendo ser um incidente, uma pessoa, uma organização, um evento, ou outro meios, ou ainda ser considerados a nível micro, relativo a pessoas, ou até a nível macro, como nos estudos de comunidades, sociedades etc. Tem o objetivo de desenvolver um retrato detalhado de algum fenômeno, contar uma história, ou ainda para dar voz a situações ou pessoas marginalizadas ou desfavorecidas (SCHWANDT; GATES, 2018). Segundo Yin (2003), pode ser uma estratégia de pesquisa interessante quando o foco está nos fenômenos dentro de algum contexto de vida real, como é o caso dessa pesquisa.

O estudo descritivo de um caso único (como neste presente relato) pode servir como parte de uma base de conhecimento para o raciocínio baseado em casos, ou até mesmo como sendo representativo de um conjunto mais amplo de casos (SCHWANDT; GATES, 2018). O caso relatado foi escolhido por dois motivos: a participante relatou, como veremos na apresentação dos resultados, mais de um caso de cura física que atribui ao tratamento espiritual. Em ambas as situações, apresentou exames de imagem que atestam a existência da moléstia antes do tratamento espiritual, e, em um dos relatos, também o exame posterior ao tratamento espiritual. As entrevistas foram audiogravadas, transcritas e analisadas utilizando o software Atlas TI, baseados nos procedimentos de análise temático-reflexiva (BRAUN; CLARKE, 2019). Seguiremos a proposição de análise das autoras denominada de tripartida, consistindo na confiabilidade da codificação, livro de códigos e abordagens reflexivas (BRAUN; CLARK, 2019).

Este projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado de Mato Grosso (CAAE nº 39055820.5.0000.5166, Parecer nº 5.166.585). Para que o caso permaneça em anonimato, preservando os critérios éticos, utilizamos um nome fictício para a participante, bem como omitimos informações que, porventura, levassem à identificação da voluntária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ana (nome fictício), mulher cisgênero, 55 anos, autodeclarada parda, solteira, com ensino superior, atualmente aposentada e trabalhadora voluntária de um centro espírita, narrou que em um exame de rotina de cuidados com sua saúde, o ultrassom detectou um nódulo na mama direita medindo 0,4 x 0,39 x 0,36 centímetros, da categoria 4 da classificação BI-RADS¹, sugerindo possível malignidade. Para a conclusão do diagnóstico foi orientada a realizar a biópsia para confirmar o tipo de células do nódulo em questão e direcionar o tratamento a ser seguido. Antes de realizar o procedimento, Ana relata ter iniciado imediatamente o tratamento espiritual com o objetivo de melhorar ou, ao menos, preparar-se espiritualmente para a biópsia.

O tratamento espiritual proposto pela casa espírita consiste em diversas atividades realizadas de forma padronizada por, no mínimo, quatro semanas de duração, perfazendo um total de, no mínimo 8 dias de frequência ao tratamento, conforme descrito a seguir: Dia 1 (segunda-feira) – Palestra de esclarecimento de rotina do tratamento espiritual, ensinamentos evangélicos, entrevista com médium treinado para a atividade, denominada de triagem fraterna, e passe; Dia 2 (terça-feira) – Palestra evangélica e passe; Dia 3 (quarta-feira) – Palestra sobre ensinamentos espíritas, passe e desobsessão; Dias 4 e 6 (terças-feiras) – iguais ao descrito no dia 2; Dias 5 e 7 (quartas-feiras) – iguais ao descrito no dia 3; Dia 8 – Retorno à triagem fraterna, palestra e passe (SOCIEDADE DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA AUTA DE SOUZA, 2008).

Antes de prosseguirmos, há que se considerar que esse protocolo é seguido pela instituição frequentada pela participante, na qual realizou o tratamento espiritual, tem uma metodologia descrita na referência supracitada e é seguida por muitas casas espíritas, embora possa não ser um padrão para as inúmeras casas espíritas espalhadas pelo Brasil. Assim, a denominação generalista “tratamento espiritual” recobre uma série de possibilidades a depender do contexto investigado, não sendo possível, necessariamente, comparar tratamentos realizados entre instituições que realizam métodos diferentes.

Ana afirma que, em uma atividade na casa espírita, durante seu tratamento espiritual, sentiu dores em sua mama direita, mas, naquele momento, não imaginou que se tratava de um possível

efeito do tratamento espiritual. Passado um mês – e após a realização do itinerário terapêutico indicado na casa em que realizou o tratamento espiritual, no momento da biópsia o nódulo não foi encontrado, tendo como conclusão do exame a ausência de formações nodulares. Ela relata que houve surpresa tanto da médica que iria realizar a biópsia, quanto da médica ginecologista ao ver a constatação do exame de biópsia:

E aí eu fiz o tratamento de um mês, quando eu retornei nela, aí fui fazer a biópsia, a punção, cheguei lá, a médica falou que não tinha mais nada né. A médica da biópsia chamou outro médico pra olhar também e não encontraram nada. Então, aí eu voltei na doutora (médica ginecologista), ela falou: - Eu não acredito, é incrível.

A participante atribuiu essa condição de cura ao tratamento espiritual realizado à época. Considerando que a prática religiosa-espiritual está fortemente marcada na cultura brasileira, é necessário valorizar a fala do sujeito entrevistado, compreendendo que a religiosidade/espiritualidade é uma dimensão que pode estar associada a sistemas explicativos no campo da saúde-doença-cuidado, pois, além de construir mecanismos de resiliência e mecanismos de proteção para o enfrentamento de situações difíceis, pode influenciar, por exemplo, em seu bem-estar (CUNHA; ROSSATO; SCORSOLINI-COMIN, 2021).

Isso posto, ainda que a cura efetiva possa não ter ocorrido, e que, na verdade, tenha havido um erro de diagnóstico inicial, temos que considerar que os benefícios obtidos pelos sujeitos que buscam por auxílio ou cura pela fé ou por curandeiros tradicionais muitas vezes são superiores a uma melhora de sintomas, por mecanismos que ainda não estão reconhecidos (NORTJE et al., 2016). É necessário pensar além da cura constatada (pelo exame), compreender o sujeito em sua complexidade, de suas perspectivas vivenciadas no processo de cura, como relatado por Laplantine (2004).

Há que se considerar, também, que os processos de cura ultrapassam a relação do saber médico. As relações de cura estão constantemente “contaminadas” pelo saber do doente sobre sua doença e a experiência vivida pelo médico (LAPLANTINE, 2004). Isso significa que nem sempre os critérios de cura ou mesmo o que é a cura é partilhado ou compartilhado por médicos e pacientes/clientes. Isso nos obriga a reconhecer as inteligibilidades nativas que habitam a comunidade de referência do paciente/cliente, as suas religiosidades/espiritualidades, em uma ampliação da lógica exclusivamente biomédica adotada pelos profissionais de saúde, em sua maioria. O próprio processo de contrastar os dois momentos do exame, pela participante, revela a necessidade de alinhamento a um discurso biomédico, de comprovação de evidências, muito embora as suas representações de saúde-doença-cura façam referência a um sistema popular e, no caso, fortemente marcado pela religiosidade/espiritualidade.

A existência de literatura científica que demonstre efetividade das terapias espíritas é uma realidade, muito embora os estudos ainda sejam escassos. Os estudos demonstram melhora de sintomas de saúde mental ou, ainda, de saúde física, percebidos pelas pessoas adoecidas, como redução da percepção de dor e de tensão muscular, ou melhora de sintomas de saúde mental, como bem-estar e ansiedade, de alteração de sinais clínicos ou laboratoriais, como na melhora da oxigenação de tecidos e alteração de resposta imunológica, entre outros parâmetros, mesmo em trabalhos controlados e cegos (CARNEIRO *et al.*, 2018; CARNEIRO *et al.*, 2017; CARNEIRO *et al.*, 2020a; CARNEIRO *et al.*, 2020b).

Ana relatou que este não foi o único processo de cura vivenciado por ela em função de um tratamento espiritual. Entre os casos de problemas de saúde física experienciados, expôs que teve

um “esporão” (nome popular para a calcificação patológica de alguma estrutura) no ombro direito que lhe ocasionava muitas dores, impossibilitando-a de realizar movimentos habituais com o braço direito, necessitando utilizar tipoia para imobilização do membro devido tamanha dor. Para Ana, este momento foi de muitas limitações, como pode ser observado em sua fala: “Estava cortando os nervos do meu ombro. Eu estava com meu braço imobilizado. Não estava conseguindo mais levantar, fazer mais nada. Segurar em nada. E muita dor, né. Muita dor e muita dor”.

Ao procurar tratamento, realizou uma ressonância magnética na qual foi constatada, como conclusão do laudo do exame, uma “artrose acromioclavicular com hipertrofia osteocapsular e osteófito marginal inferior que determina redução no espaço subacromial; tendinose supraespinhal moderada, associada a pequena ruptura transfixante próximo a inserção, sem retração significativa do coto distal”, entre outras impressões diagnósticas. Segundo Ana, o médico ortopedista sugeriu tratamento clínico inicialmente como drogas anti-inflamatórias. Contudo, esclareceu que a realização de uma cirurgia para raspagem e colocação de uma prótese (no ombro) como o único meio disponível para resolver definitivamente a sua situação.

Devido à complexidade da cirurgia, Ana optou por realizar tratamento clínico e espiritual concomitantemente (seguindo, para o tratamento espiritual, o mesmo protocolo anteriormente relatado). Entretanto, aproximadamente após três meses de uso contínuo de diversas medicações, Ana decidiu parar o tratamento biomédico instituído e seguir somente com o tratamento espiritual contínuo.

Segundo ela, o tratamento espiritual, desta vez, foi longo (quase um ano), de forma ininterrupta, com intenso empenho e fé em sua cura. Passados meses de seu quadro de dor, durante uma atividade de trabalho mediúnico no centro espírita, percebeu que tocaram em seu ombro direito (algo que não era esperado na atividade realizada). Após esse dia, Ana percebeu que suas dores foram diminuindo, e considerou-se curada das dores no ombro e braço após aproximadamente 30 dias do ocorrido. A cura foi por ela atribuída ao tratamento espiritual ocorrido durante a atividade mediúnica.

Notamos, aqui, que o critério para atribuição de cura ou de remissão de sintomas não segue a lógica biomédica, que demandaria, no caso, de exames clínicos ou de imagem para atestar possíveis modificações em seu quadro. A cura, em seu relato, emerge a partir de sua experiência, sendo constatada a partir da ausência definitiva de sintomas. No caso, para além de uma explicação que toma por base a crença depositada no tratamento espiritual, podemos notar a ocorrência de um sinal (o toque no ombro), significado por ela, desde então, como algo que marcara o seu itinerário terapêutico. Esse sinal para simbolizar, em seu itinerário, o início da cessação da sua dor e dos demais sintomas associados, assinalando, possivelmente, que um desfecho positivo (de cura) estava próximo. Esse toque não está prenhe de sentidos, *a priori*, mas torna-se significativo a partir da etnoteoria nativa dessa participante, que atribui a esse evento um significado particular e que possibilita, um mês depois, a sua cura definitiva, segundo o modelo explicativo por ela partilhado.

Além desses dois eventos, também relatou uma outra situação de cura de um nódulo nas cordas vocais, que lhe ocasionou rouquidão por mais de quatro meses, tendo uma resolução positiva também atribuída ao tratamento espiritual. E o caso de uma apendicite grave, resolvida sem maiores complicações.

Como mencionado anteriormente, estudos clínicos, randomizados, duplos-cegos já demonstraram relação positiva na utilização de terapias espíritas como o passe (imposição de mãos) na recuperação física ou de construtos de saúde mental. Por exemplo, o estudo de Zacaron *et al.* (2021) evidenciou a melhora da capacidade funcional de mulheres com osteoartrite de joelho no grupo

que recebeu o passe espírita – um tipo de tratamento espiritual, quando comparado com o grupo que recebeu outra forma de imposição de mãos, mas que não tinha o envolvimento da dimensão espiritual e/ou sem intenção de cura. Relataram, ainda, melhoras de outros parâmetros avaliados como dor, capacidade funcional, depressão e ansiedade quando comparado com o grupo controle, que somente recebeu a cinesioterapia (ZACARON *et al.*, 2021).

Uma metanálise que analisou a utilização de intervenções espirituais realizadas por enfermeiros concluiu que as intervenções espirituais parecem ser eficazes para promover a saúde, como visto para a saúde mental, espiritualidade, bem-estar e de resultados físicos (DIEGO-CORDERO *et al.*, 2022). Outra metanálise que avaliou a eficácia percebida de tratamentos com a utilização da fé ou cuidadores tradicionais em cuidados de saúde, identificou vários estudos que relataram a relação positiva entre eles, principalmente quando os cuidados pela fé ou tradicionais eram associados aos cuidados biomédicos (VAN DER WATT *et al.*, 2018). Outro estudo de revisão sistemática e metanálise evidenciou que as intervenções espirituais resultaram em redução do estresse, do alcoolismo e da depressão (GONÇALVES *et al.*, 2015).

Podemos perceber, nas falas da participante deste estudo, uma forte expectativa de cura a partir do tratamento espiritual, como nas seguintes passagens: “Eu busquei o tratamento espiritual pra trabalhar a fé e curar”; “Aí eu falei pra ela (para a médica mastologista): - Só depois do tratamento espiritual. Eu falei, eu tenho fé. Vai curar, não vai precisar fazer nada. Eu tenho, só quero um mês”. Ou, ainda: “Enquanto eu não curo, eu não paro de fazer, entendeu como que é?”, e, em outra situação: “Um ano e eu tive que esperar (a cura do esporão). E eu tive paciência comigo mesma, esperando com muita oração e tratamento espiritual até eu curar”. Ao mesmo tempo que essas frases podem ser interpretadas como fé e confiança no tratamento, por outro lado podem demonstrar um adiamento da procura dos tratamentos de saúde formais, podendo ser interpretado como um possível aspecto negativo das crenças e práticas religiosas em saúde.

Do ponto de vista biomédico, segundo Koenig (2005), a situação relatada pela participante pode ser vista como preocupante, pois a religião foi usada em substituição ao tratamento médico regular. Pode-se considerar como um aspecto negativo quando os tratamentos formais são evitados ou até mesmo descontinuados devido aos fundamentos religiosos. Na metanálise já citada anteriormente (VAN DER WATT *et al.*, 2018), os autores também identificaram relações negativas entre tratamentos pela fé e cuidados em saúde no continente africano. A relação negativa foi apontada quando os tratamentos baseados na fé incluíam situações de violência como utilização de correntes para aprisionar o doente ou até mesmo chicotadas.

Do ponto de vista religioso, a fé é essencial para o alcance de qualquer necessidade. Para isso, expressões cristãs como “a fé move montanhas” são postuladas como fundamentais aos fiéis que procuram por entidades religiosas como recurso para resolução de seus problemas. Do ponto de vista científico, já existem estudos que demonstram a relação entre esses aspectos e os desfechos positivos. Um estudo de revisão evidenciou que intervenções baseadas na fé, tais como oração, leitura evangélica e/ou religiosa, meditação, jejum, atenção plena, entre outros, são eficazes tanto no controle do diabetes como na redução dos níveis da doença. Além disso, o estudo sugere a implementação de uma metodologia baseada na fé que possa ser replicada em diferentes contextos e populações (ONYISHI *et al.*, 2021). Outro estudo, que objetivou aumentar a atividade física e reduzir a pressão arterial em mulheres sedentárias utilizando um protocolo multidisciplinar incluindo a fé, observou a redução do sedentarismo e da pressão arterial das participantes (KENRIK DURU *et al.*, 2010).

Na publicação organizada por Tavares e Giumbelli (2015) foram reunidos diversos trabalhos que versam sobre a fé em diferentes seguimentos religiosos, e um dos trabalhos cita uma carac-

terística sobre a fé consoante ao relatado por nossa entrevistada: na ausência da fé não se tem o resultado porque, simplesmente, o elemento, no processo, não teria eficácia nem a capacidade de desencadear a cura (MORENO; BASSI, 2015). Diante das circunstâncias apresentadas, podemos considerar que a fé pode ser frequentemente usada como recurso para ajudar a superar crises pessoais e, juntamente com abordagens como o estabelecimento de metas pessoais, podem ajudar a superar obstáculos (KENRIK DURU *et al.*, 2010).

É importante considerar, aqui, que a literatura científica vem reconhecendo a necessidade de incorporar diferentes modalidades de cuidado, permitindo um cuidado que, de fato, seja integral. Quando os tratamentos formais e de ordem biomédica se recusam a reconhecer e acolher os relatos de tratamentos realizados em equipamentos populares de saúde, a exemplo dos realizados em centros espíritas, desconsidera-se as etnoteorias trazidas pelo sujeito.

Não se trata, pois, de reconhecer a importância desses cuidados apenas quando há indícios ou evidências de efetividade desses tratamentos ditos espirituais, mas de permitir a escuta do sujeito, conhecer o seu universo de referência e, mais do que isso, fomentar a importância de um cuidado compartilhado, integral, que faça uso tanto dos recursos médicos existentes quanto do apoio oferecido, por exemplo, em equipamentos populares de cura. O que deve ser combatido, como apresentado no caso em tela, são as atitudes que, por exemplo, negam a existência de outras possibilidades de cuidado para além dos equipamentos formais de saúde, além de posturas que indiquem o tratamento espiritual como única resposta, sobretudo no caso de patologias identificadas e com boas chances de desfecho positivo a partir dos itinerários em sistemas formais. Deve-se primar, pois, por um cuidado integrado, o que pressupõe a compreensão, a convivência e a valorização de ambas as formas de cuidado, sem a emissão de juízos de valor e de realidade, sobretudo por parte dos profissionais de saúde em relação aos tratamentos e às inteligibilidades não-hegemônicas e não sustentadas exclusivamente no saber biomédico (SCORSOLINI-COMIN, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir deste caso, discute-se que não se trata de buscar comprovações para as afirmações desse sujeito, ou seja, se houve ou não a cura do ponto de vista físico – o que reforçaria a primazia do modelo biomédico, mas, sim, de acolhimento da sua experiência e acompanhamento de seu itinerário em relação aos processos de saúde-doença-cuidado, em uma abertura para a escuta e a consideração das etnoteorias. O relato de caso, como o explorado mais detidamente no presente estudo, portanto, deve contribuir para expandir a visão para situações pouco conhecidas pela pesquisa científica, permitindo a integração de diferentes inteligibilidades. O método empregado no presente estudo, embora possa ser considerado frágil pela impossibilidade de produção de evidências robustas para a prática, isso tomando como base uma postura biomedicalizante e positivista, é aqui alçado a uma condição de permitir justamente a escuta daquilo que, de outro modo, não se revelaria diante de um profissional de saúde, por exemplo. Assim, os equipamentos populares de cuidado parecem estar mais sensíveis a não escutarem apenas aquilo que se refere aos seus contextos, mas diferentes lógicas explicativas, o que não parece se dar quando o centro do cuidado se desenvolve em um equipamento formal, muito menos poroso a escuta do que lhe é externo.

Como pesquisadores no campo da etnopsicologia, é mister que nos afastemos de quaisquer tentativas de julgamento moral ou de realidade em relação ao relato em tela. O acolhimento das diferentes experiências de saúde-doença-cuidado, sobretudo no campo da atuação em saúde, em uma posição de respeito e de genuíno interesse, pode contribuir para a integração de diferentes

inteligibilidades e para a desconstrução de posturas desacolhedoras quando pacientes/clientes compartilham suas religiosidades/espiritualidades. A partir do caso aqui discutido em profundidade, revela-se a necessidade de considerar os critérios de cura não a partir do que tradicionalmente, na ciência, apregoa-se como tal, mas situando esse conceito dentro de um referencial no qual o sujeito vive, relaciona-se e produz inteligibilidades sobre si, sobre seu meio e sobre o seu mundo.

PHYSICAL HEALING ATTRIBUTED TO SPIRITUAL TREATMENTS IN SPIRITISM: CASE REPORT

Abstract: the scientific literature has reported cases of patients who had improvement in health symptoms attributed to spiritual interventions. The objective of this study is to report a case of physical healing of a breast lump attributed to a spiritual treatment (ST). This is a case study developed from a qualitative approach, through an interview carried out in a spiritist center. One woman reported that, after detecting a breast nodule with malignant characteristics, she underwent ST. In the subsequent biopsy no nodular formations were identified. The participant attributed this condition to the ST effect. As researchers in the field of ethnopsychology, it is imperative that we move away from moral judgment or reality in relation to the story on screen. Embracing different health-disease-care experiences, especially in the field of health care, in a position of respect and genuine interest, can contribute to the integration of different intelligibility.

Keywords: *Spiritism. Spiritual Therapies. Spirituality.*

Nota

- 1 Breast Image Reporting and Data System: Classificação internacional para laudos de exames de imagem de mama, que variam de 0 a 6 de acordo com grau de suspeita dos achados.

REFERÊNCIAS

- AUBRÉE, M.; LAPLANTINE, F. *A mesa, o livro e os espíritos: gênese, evolução e atualidade do movimento social espírita entre França e Brasil*. Tradução Maria Luiza Guarnieri Atik et al. Maceió: EDUFAL, 2009. 403p.
- BRAUN, V.; CLARKE, V. Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, v. 11, n. 4, p. 589-597, 2019. DOI: 10.1080/2159676X.2019.1628806.
- CARNEIRO, E. M.; BARBOSA, L. P.; BITTENCOURT, A. C.; HERNÁNDEZ, C. G.; TIMÓTEO, R. P.; ALMEIDA, C. O.; BORGES, M. F. Effects of Spiritist "passe" (Spiritual healing) on stress hormone, pain, physiological parameters and length of stay in preterm newborns: A randomized, double-blind controlled trial. *Journal of Complementary and Integrative Medicine*, 20180015, 2018. DOI: 10.1515/jcim-2018-0015.
- CARNEIRO, E. M.; BARBOSA, L. P.; MARSON, J. M.; TERRA JUNIOR, J. A.; MARTINS, C. J. P.; MODESTO, D.; RESENDE, L. A. P. R.; BORGES, M. F. Effectiveness of Spiritist "passe" (Spiritual healing) for anxiety levels, depression, pain, muscle tension, well-being, and physiological parameters in cardiovascular inpatients: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Medicine*, v. 30, p. 73-78, 2017. DOI: 10.1016/j.ctim.2016.11.008.
- CARNEIRO, E. M.; OLIVEIRA, L. F. A.; DA SILVA, D. A. A.; SOUSA, J. B. F.; TIMÓTIO, R. P.; BARBOSA NETO, O.; SILVA, A. P.; RODRIGUES JUNIOR, V.; RESENDE, L. A. P. R.; BORGES, M. F. Effects of the laying on of hands on anxiety, stress and autonomic response of

employees in a hospital: A double-blind randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Medicine*, v. 52, 102475, 2020a. DOI: 10.1016/j.ctim.2020.102475.

CARNEIRO, E. M.; TOSTA, A. D. M.; ANTONELLI, I. B. S.; SOARES, V. M.; OLIVEIRA, L. F. A.; BORGES, R. M. C.; SILVA, A. P.; BORGES, M. F. Effect of Spiritist "Passe" on Preoperative Anxiety of Surgical Patients: A Randomized Controlled Trial, Double-Blind. *Journal of Religion and Health*, v. 59, n. 4, p. 1728-1739, 2020b. DOI: 10.1007/s10943-019-00841-7.

CAVALCANTE, R. S.; BANIN, V. B.; PAULA, N. A. M. R.; DAHER, S. R.; HABERMANN, M. C.; HABERMANN, F.; BRVIN, A. M.; SILVA, C. E. C.; ANDRADE, L. G. M. Effect of the Spiritist "passe" energy therapy in reducing anxiety in volunteers: A randomized controlled trial. *Complementary Therapies in Medicine*, v. 27, p. 18-24, 2016. DOI: 10.1016/j.ctim.2016.05.002.

CUNHA, V. F.; ROSSATO, L.; SCORSOLINI-COMIN, F. Religião, religiosidade, espiritualidade, ancestralidade: tensões e potencialidades no campo da saúde. *Relegens Thréskeia: Estudos e Pesquisa em Religião*, v. 10, n. 1, p. 143-170, 2021.

DIEGO-CORDERO, R. De; SUÁREZ-REINA, P.; BADANTA, B.; LUCCHETTI, G.; VEGA-ESCAÑO, J. The efficacy of religious and spiritual interventions in nursing care to promote mental, physical and spiritual health: A systematic review and meta-analysis. *Applied Nursing Research*, v. 67, p. 151618, 2022.

GONÇALVES, J. P. B.; LUCCHETTI, G.; MENEZES, P. R.; VALLADA, H. Religious and spiritual interventions in mental health care: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Psychological Medicine*, n. 45, p. 2937-2949, 2015. DOI:10.1017/S0033291715001166

GUREJE, OYE; NORTJE, GARETH; MAKANJUOLA, VICTOR; OLADEJI, BIBIOLA D.; SEEDAT, SORAYA; JENKINS, RACHEL. The role of global traditional and complementary systems of medicine in the treatment of mental health disorders. *Lancet Psychiatry*, n. 2, p. 168-177, 2015.

KARDEC, Allan. *A gênese*. Tradução Evandro Noleto Bezerra. 2. ed. Brasília: FEB, 2013. 411p.

KENRIK DURU, O.; SARKISIAN, C. A.; LENG, M.; MANGIONE, C. M. Sisters in Motion: A Randomized Controlled Trial of a Faith-Based Physical Activity Intervention. *Journal of the American Geriatrics Society*, v. 58, n. 10, p. 1863-1869, 2010. DOI:10.1111/j.1532-5415.2010.03082.x.

KOENIG, H. G. *Espiritualidade no cuidado com o paciente*. Por quê, como, quando e o quê. São Paulo: FE, 2005.

LANGDON, E. J. Os diálogos da antropologia com a saúde: contribuições para as políticas públicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, n. 4, p. 1019-1029, 2014.

LANGDON, E. J.; WILK, F. B. Antropologia, saúde e doença: uma introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, n. 3, 2010.

LAPLANTINE, F. *Antropologia da doença*. Tradução Valter Lelis Siqueira. São Paulo: Marins Fontes, 3. ed., 2004. 274p.

LUCCHETTI, A. L. G.; LUCCHETTI, G.; LEÃO, F. C.; PERES, M. F. P.; VALLADA, H. Mental and Physical Health and Spiritual Healing: An Evaluation of Complementary Religious Therapies Provided by Spiritist Centers in the City of São Paulo, Brazil. *Culture, Medicine, and Psychiatry*, v. 40, p. 404-421, 2015. Doi 10.1007/s11013-015-9478-z.

MELO, L. P.; CABRAL, E. R. M.; SANTOS JÚNIOR, J. A. The health-disease process: a reflection based on medical anthropology. *Revista de Enfermagem UFPE online*, v. 4, n. 3, p. 426-432, 2009.

- MONTERO, P. *Da doença à desordem: a magia na umbanda*. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 285p.
- MOREIRA-ALMEIDA, A.; COSTA, M. de A.; COELHO, H. S. *Science of Life After Death*. Cham, Switzerland: Springer, 2022. 96p.
- MORENO, Á. R.; BASSI, F. Religião e cura numa igreja pentecostal em Itaparica-Bahia. In: TAVARES, F.; GIUMBELLI, E. (org.). *Religiões e temas de pesquisa contemporâneos: diálogos antropológicos*. Salvador: EDUFBA, ABA Publicações, 2015.
- NORTJE, G.; OLADEJI, B.; GUREJE, O.; SEEDAT, S. Effectiveness of traditional healers in treating mental disorders: a systematic review. *Lancet Psychiatry*, v. 3, p. 154-170, 2016.
- ONYISHI, C. N.; ILECHUKWU, L. C.; VICTOR-AIGBODION, V.; ESEADI, C. Impact of spiritual beliefs and faith-based interventions on diabetes management. *World Journal of Diabetes*, v. 12, n. 5, p. 630-641, 2021. DOI: 10.4239/wjd.v12.i5.630 I.
- PHAM, T. V.; KOIRALA, R.; WAINBERG, M. L.; KOHRT, B. A. Reassessing the Mental Health Treatment Gap: What Happens if We Include the Impact of Traditional Healing on Mental Illness? *Community Mental Health Journal*, v. 57, p. 777-791, 2021. DOI: 10.1007/s10597-020-00705-5.
- SCHWANDT, T. A.; GATES, E. F. Case Study Methodology. In: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. S. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 5. ed. 2018. p. 600-630.
- SCORSOLINI-COMIN, F. Escuta é perfume: por uma clínica etnopsicológica. In: SCORSOLINI-COMIN, F.; BAIRRÃO, J. F. M. H. (orgs.). *Etnopsicologia e saúde*. São Carlos: Pedro e João Editores, 2023. p. 55-78.
- SCORSOLINI-COMIN, F. É como mexer em um vespeiro: a consideração das religiões afro-brasileiras no cuidado em saúde. *Revista da SPAGESP*, Ribeirão Preto, v. 19, n. 1, p. 1-5, 2018.
- SILVA, L. M. F.; SCORSOLINI-COMIN, F. Na sala de espera do terreiro: uma investigação com adeptos da umbanda com queixas de adoecimento. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 29, n. 1, p. e190378, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0104-12902020190378>. Acesso em: 12 mar. 2023.
- SOCIEDADE DE DIVULGAÇÃO ESPÍRITA AUTA DE SOUZA (ed.). *Compreendendo a dor humana*. Taguatinga: Auta de Souza, 2008.
- VAN DER WATT, A. S. J., VAN DE WATER, T., NORTJE, G., OLADEJI, B. D., SEEDAT, S., GUREJE, O. The perceived effectiveness of traditional and faith healing in the treatment of mental illness: a systematic review of qualitative studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, n. 53, p. 555-566, 2018. DOI: 10.1007/s00127-018-1519-9.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Comprehensive mental health action plan 2013-2030*. Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 2021.
- YIN, R. K. *Case Study Research: Design and Methods*. 3 ed. Thousand Oaks: Sage, 2003.
- ZACARON, K. A. M.; DOS SANTOS, C. S.; CORRÊA, C. P. S.; COTTA E SILVA, Y.; REIS, I. C. F.; SIMÕES, M. S.; LUCCHETTI, G. Effect of laying on of hands as a complementary therapy for pain and functioning in older women with knee osteoarthritis: A randomized controlled clinical trial. *International Journal of Rheumatic Diseases*, v. 24, n. 1, p. 36-48, 2021.